

ความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคไม่ติดต่อ ตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ

Health literacy based on principles of “3E. 2S.” among risk persons
of non-communicable diseases at Tambon Na Fai in Changwat Chaiyaphum

พรภัทรา แสนเหลา* สุวารี ทวนวิเศษกุล* ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์* และสมัคร ตาปราบ**

Pornphattra Sanloa,* Suwaree Tuanwisetkul,* PanKarin Hoyrat.* and Samuak Taprap**

*คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

**โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย

*Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University

**Na Fai Tambon Health Promotion Hospital

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา) ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 394 คน เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือวิจัยเป็นแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของคนไทยกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตน การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ และการมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม (37.6%, 40.1%, และ 46.6% ตามลำดับ) ส่วนที่มีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง (59.6%, 48.7%, 39.3% และ 74.9%. ตามลำดับ) ผู้ที่คงดูแลรักษาสุขภาพตนเองมีพฤติกรรมมารับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และอารมณ์อยู่ระดับปานกลาง มีร้อยละ 76.9 58.1 และ 75.4 ตามลำดับ ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ในระดับน้อย มีร้อยละ 47.0 และดื่มสุราอยู่ในระดับมาก มีร้อยละ 45.4

คำสำคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ประชาชนกลุ่มเสี่ยง, โรคไม่ติดต่อ

ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Corresponding author E-mail: PP_sanloa@hotmail.com

วันที่รับบทความ: 14 เมษายน 2565 วันที่แก้ไขบทความ: 8 พฤษภาคม 2565 วันที่ตอบรับบทความ: 20 มิถุนายน 2565

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุร่วมสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อในระดับประชากร ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยง คือ การสูบบุหรี่ การบริโภคแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล หวานเกิน มันเกิน เค็มเกิน การออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงมากขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็นสภาพวิถีชีวิตที่เร่งด่วน ภาวะเครียด การใช้ชีวิตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาก เคลื่อนไหวน้อย มีภาวะเนือยนิ่งมากขึ้น การบริโภคมากขึ้น (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2564)

กลุ่มวัยทำงานควรปฏิบัติตามหลัก 3 อ. 2 ส. ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังได้ดังนี้ **อ.ที่ 1 คือ อาหาร** รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ครบทั้ง 5 หมู่ ลดความหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ำมันซ้ำหลาย ๆ ครั้ง กินอาหารหลากหลายไม่จำเจ **อ.ที่ 2 คือ ออกกำลังกาย** การออกกำลังกายทำให้แข็งแรง อายุยืน โดยออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที และทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน **อ.ที่ 3 คือ อารมณ์** เลือกริธีที่ถนัด สนใจ ทำแล้วเพลิดเพลิน ลดความเครียด มีความสุข เช่น ฟังเพลง ร้องเพลง ดูโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน ปลูกต้นไม้ พุดคุย พบปะกับเพื่อนฝูง **ส.ที่ 1 คือ ลดการสูบบุหรี่** การสูบบุหรี่ทำให้หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นมะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ปอดอุดตันเรื้อรัง และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ **ส.ที่ 2 คือ ลดการดื่มสุรา** การดื่มสุราทำให้ความดันโลหิตสูง เกิดโรคหัวใจ เพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นตับอักเสบ ตับแข็ง ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนควรปฏิบัติตามหลัก 3 อ. 2 ส. จะทำให้มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ กลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป สามารถหาความรู้สุขภาพที่ถูกต้อง และเข้าใจง่ายผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. (อาหาร

ออกกำลังกาย อารมณ์) 2 ส. (เหล้า บุหรี่) ในการควบคุม 5 โรคเรื้อรังอันตราย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็งกับกลุ่มเป้าหมายประชาชนวัยทำงานทั่วประเทศที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของตำบลจัดการสุขภาพซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพื่อลด 5 โรคเรื้อรังครอบคลุม 76 จังหวัด (ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์, 2561)

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 1998) ได้อธิบายความหมายของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ว่า หมายถึง ทักษะทางการรู้และสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนดแรงจูงใจและความ สามารถของปัจเจกบุคคล ในการที่จะเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลในวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สุขภาพรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นผลลัพธ์ขั้นสูงของกระบวนการทางสุขศึกษา ร่วมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับสูง ช่วยเพิ่มทักษะชีวิต ส่งผลเกื้อหนุนสุขภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชน กล่าวได้ว่าการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ (อรวรรณ นามมนตรี, 2561)

ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นทักษะของบุคคลในการดูแลสุขภาพ เป็นการบรรลุถึงระดับความรู้ ทักษะส่วนบุคคลและความมั่นใจในการปฏิบัติเพื่อช่วยให้สุขภาพของตนเองและชุมชนดีขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ เป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจและการใช้ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540 อ้างใน เกศินี สราญฤทธิ์ชัย, 2564) ความรู้ด้านสุขภาพมีความสำคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพ ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูล ประเมินข้อมูลนำข้อมูลนั้นมาใช้

ในการปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ อันจะส่งผลให้มีสุขภาพดี (เกศินี สราญฤทธิชัย, 2564)

อัตราป่วยด้วยโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี 2559-2561 เท่ากับ 1770.04, 16.23.41 และ 2054.58 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ อัตราป่วยโรคเบาหวาน เท่ากับ 1457.30, 1531.28 และ 1619.20 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ และอัตราป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 338.67, 358.56 และ 367.55 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ เป็นต้น (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ, 2563) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีอายุ 35-59 ปี ในตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. ศึกษาความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีอายุ 35-59 ปี ในตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วิธีดำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร เป็นประชาชน ในตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่มีอายุ 35-59 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 394 คน เลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นจาก 19 หมู่บ้านของตำบลนาฝาย

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรคำนวณของ

Yamane (1973) โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน .05 และระดับความเชื่อมั่น 0.95 ได้ขนาดตัวอย่าง 358 คน

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบวัดความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของคนไทย กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ของกองสุขาภิบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอ้างอิงจาก Ungsinun Intarakamhang และ Yuttapong Kwanchuen. (2016) มี 8 องค์ประกอบซึ่งอยู่ในตอนที่ 2-9 ดังนี้

ตอนที่ 1 **ข้อมูลทั่วไป** ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภาวะสุขภาพ ได้แก่ รูปร่าง ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ประวัติการแพ้ของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ

ตอนที่ 2 **ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนตาม 3 อ. 2ส.** จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน แบ่งเป็นระดับน้อยได้ 0-4 คะแนน ระดับปานกลาง ได้ 5-7 คะแนน ระดับมากได้ 8-10 คะแนน

ตอนที่ 3 **การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3 อ. 2ส.** จำนวน 5 ข้อ (20 คะแนน) คำถามเชิงบวก 4 ข้อ คำถามเชิงลบ 1 ข้อ แบ่งเป็น ระดับน้อยได้ 0-8 คะแนน ระดับปานกลาง ได้ 9-15 คะแนน ระดับมากได้ 16-20 คะแนน

ตอนที่ 4 **การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส.** จำนวน 6 ข้อ (24 คะแนน) คำถามเชิงบวก 4 ข้อ คำถามเชิงลบ 2 ข้อ แบ่งเป็น ระดับน้อยได้ 0-9 คะแนน ระดับปานกลาง ได้ 10-19 คะแนน ระดับมากได้ 20-24 คะแนน

ตอนที่ 5 **การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส.** จำนวน 5 ข้อ (20 คะแนน) แบ่งเป็น ระดับน้อยได้ 0-8 คะแนน

การอภิปรายผลการวิจัย

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตาม 3อ. 2ส. การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. และการมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพทางสังคมอยู่ในระดับน้อย มีการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพหลัก 3อ. 2ส. การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก 3อ. 2ส. อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และสื่อโทรทัศน์ทำให้เกิดการพิจารณาไตร่ตรองประมวลผลข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นจนเกิดการตกตะกอนกลายเป็นความรู้ความเข้าใจอันนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกองสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งกล่าวว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติความรู้ความเข้าใจ เป็นทักษะของบุคคลในการจำ ทำความเข้าใจในข้อมูลที่ได้จากการฟัง พูด อ่าน หรือเขียนและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (เกศินี สราญฤทธิชัย, 2564) สอดคล้องกับผลงานวิจัยจากหลายเรื่องได้แก่ อารีย์ แร่ทอง (2562) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอายุ 15-45 ปี ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ระดับพอใช้ ร้อยละ 66.67 และอายุ ≥ 46 ปีขึ้นไปมี ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพอใช้ ร้อยละ 60.68 ธัญชนก ชุมทอง, วิราภรณ์ โพธิศิริ, และขวัญเมือง แก้วดำเกิง (2559) พบว่า ร้อยละ 62.7 ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัด

อุทัยธานีและอ่างทองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำมากที่สุด เสาวภา ดงหงส์, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, และพรณา หอมสินธุ์ (2564) พบว่าทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในภาพรวมไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านความเข้าใจ ด้านการเปลี่ยนพฤติกรรมและการบอกต่อ และด้านการได้ตอบซักถาม

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 47 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่ในระดับน้อย มีพฤติกรรมด้านอาหาร (76.9%) การออกกำลังกาย (58.1%) ด้านอารมณ์ (75.4%) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการดื่มสุรามีในระดับมาก (45.4%) ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ซึ่งมีผลการวิจัยของ นริศรา แก้วบรรจักษ์, ประไพจิตร ชุมแวงวาปี, และกฤษกันทร สุวรรณพันธุ์ (2563) ที่พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ และสมใจ วจิณกุลและนุศทิพย์ แสนคำ (2559) ที่พบว่า อายุและพฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

1. การวางแผนดำเนินการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่ประชาชนวัยทำงาน ควรควบคุมและลดพฤติกรรมเสี่ยงตามหลัก 3อ. 2ส. ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ ให้เข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพทางสังคม
2. ควรทำวิจัยถึงทดลองศึกษาอิทธิพลของความรอบรู้สุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง